

시험 관영 코멘트



불안은 정신과적 질환 외에 기질적인 질환에 의해서도 유발될 수 있습니다.

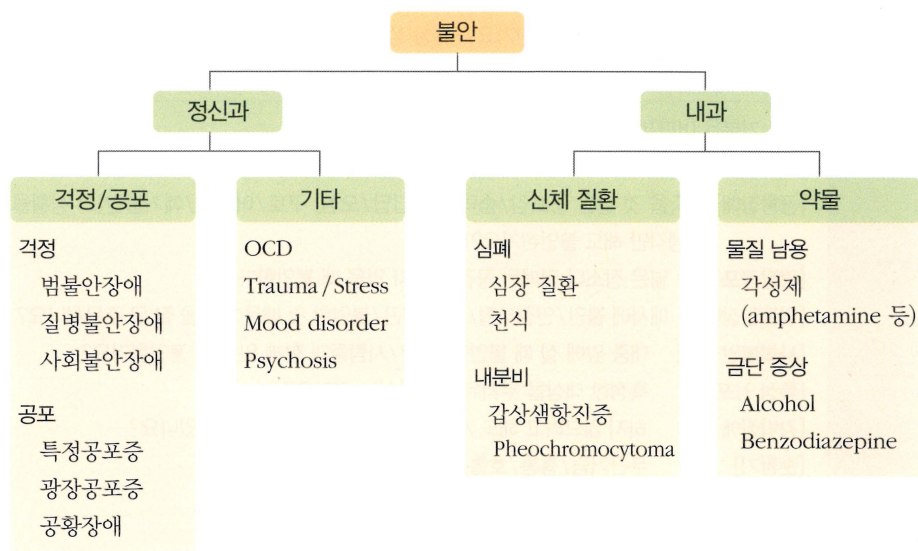
불안에서는 다양한 신체 증상이 동반될 수 있으며, 두근거림, 호흡곤란 등의 증상은 두 가지 경우 모두에서 나타날 수 있으므로 문진과 신체 검진을 통해 구분해야 합니다. 또한 카페인 섭취가 과도할 경우 카페인 자체에 의해서 불안감이 유발될 수 있습니다. 이 경우 카페인을 끊어 증상이 호전되는지 봐야 합니다. **스트레스를 받는 상황에 대하여 지지적으로 상담해주고, 큰 문제가 아니고 앞으로 좋아질 것이라고 암시하며 안심시켜 주는 것이 필요합니다.**

불안 때문에 너무 힘들 경우 약물 치료로 도움을 줄 수 있을 것입니다. 죽을 것같은 공포심과 불안감을 느끼는 환자에게는 이러한 불안감이 생명에는 전혀 지장이 없는 것이기 때문에 걱정하지 말고 대개 자연적으로 소실된다고 안심시키는 것이 가장 중요합니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
원발성		공황장애★ (panic disorder)	반복적이고 예기치 못한 공황 발작, 예기불안/발작에 대한 근심/행동 변화	Benzodiazepin(급성), SSRI(만성), 인지 행동 치료
		광장공포증★ (agoraphobia)	공황 발작이나 유사 증상이 생긴 경우 도움을 받기 어려운 장소에 있는 것 불안해 함	SSRI, 인지 행동 치료
		외상 후 스트레스 장애★ (PTSD)	1개월 이상(이하면 급성 스트레스 장애), 자신·타인의 죽음, 신체 손상 등 경험/직면, 극심한 공포, 무력감, 과각성/재경험(악몽)/회피	SSRI, TCA, 외상 직후 단기간 위기 개입(제반응), 인지 행동 치료(지속 노출 치료, 인지 처리 치료, 안구 운동 탈민감재 처리)
		범불안장애★ (generalized anxiety disorder)	스스로 조절이 안 되는 지나친 걱정과 불안 증상이 6개월 이상 지속, 수면장애, 안정불안, 피로감, 근육의 긴장	Buspirone, Benzodiazepine, SSRI 인지 행동 치료(이완, 바이오피드백)

원발성	강박장애★ (obsessive compulsive disorder)	강박 사고나 강박 행동, 생활에 지장을 줌	SSRI(고용량, 장기 투약), 행동 치료(노출과 반응 방지, 탈감작, 사고 중지)
	적응장애★ (adjustment disorder)	알 수 있는 정신/사회적 스트레스가 작용한 지 3개월 이내에 부적합한 적응 반응(심한 불안)	단기 정신 치료, 인지 행동 치료, 대인 관계 치료, 불안 심한 경우 BZD
	사회불안장애★ (social anxiety disorder)	사회적 활동에 대한 두려움, 사회적 상황에 처하면 항상 불안 유발	Beta blocker, SSRI, Benzodiazepine, 인지 행동 치료, 집단 치료
속발성	호흡기 천식 (asthma)	[병력] 쌕쌕거림, 기침, 호흡곤란, 계절성 [검진] 흉부 청진에서 쌕쌕거림	[검사] 폐기능검사, 메타콜린 자극 유발검사, 기관지확장제검사 [치료] SABA, ICS
	내분비 갑상샘항진증 (hyperthyroidism)	[병력] 체중 감소, 더위불내성, 두근거림 [검진] 갑상샘 촉진	[검사] TFT [치료] Propylthiouracil, Methimazole, 방사성 요오드 치료
	신경 크롬친화세포종 (pheochromocytoma)	[병력] 두통, 안면홍조, 식은땀, 두근거림 [검진] 복부 촉진	[검사] 24시간 요중 메타네프린, 복부 CT [치료] Phenoxybenzamine, Propranolol, 부신절제술
	순환기 허혈 심장병 (ischemic heart disease)	[병력] 흉통, 호흡곤란, 운동 시 악화 [검진] 심장 청진	[검사] 심전도, 운동부하심전도, 심근관류 스캔 [치료] 아스피린, 클로피도그렐, 관상동맥재개통술
	순환기 빠른 부정맥 (tachyarrhythmia)	[병력] 두근거림, 심장쿵, 맥박 측정 [검진] 심장 청진	[검사] 심전도, Holter monitoring [치료] 항부정맥제
	신경 뇌전증 (epilepsy)	[병력] 발작, 전조 증상, 이전 뇌손상력 [검진] 신경학적 이상 소견	[검사] EEG, 뇌 MRI [치료] 항뇌전증제
	약물 약물 금단	[병력] 약물 남용 병력(알코올, 신경안정제 등)	[검사] - [치료] Haloperidol, Benzodiazepine



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제 처음 불안감을 느끼셨나요? / 갑자기 시작되었나요? 특별한 사고나 사건이 있었나요? → 그 사고 후 그 사건에 대한 악몽을 자주 꾸시나요? 그 사고 후 비슷한 상황을 자주 피하게 되나요?
L	-
D	한번 불안하면 얼마나 지속되나요? / 얼마나 자주 증상을 경험하시나요?
Co	증상이 점점 더 자주 발생하나요?
Ex	이전에도 이런 일이 있었나요? / 그것과 관련해서 정신과 치료를 받은 적이 있나요?

C	[Open] 불안감이 시작된 상황에 대해서 설명해주시겠어요? (특정 장소와 연관이 있는지?) [양상] 불안할 때 드는 생각이 있나요? [정도] 불안이 어느 정도로 심한가요?/일상 생활에 지장이 있나요? 불안할 때 죽고 싶은 생각도 드나요?
A	지금 기분은 어떠세요? [Open] 불안과 동반되는 증상에는 어떤 것들이 있나요? [공황장애] 죽을 것 같은 공포감/숨막히고 답답/오심, 구토/어지럼/예기불안(그 상황을 생각만 해도 불안한가요?) [광장공포증] 넓은 장소나 밀폐된 공간에 혼자 있을 때 불안한가요? [범불안장애] 매사에 불안/안절부절/쉽게 피곤/불안한 것 때문에 잠을 잘 못 주무시나요? [사회불안장애] 대중 앞에 설 때 불안한가요?/사람들과 함께 있는 것 불안한가요? [특정 공포증] 특정한 대상을 무서워서 피하시는 건가요? [강박장애] 하지 않으려고 해도 자꾸 반복되는 생각이나 행동이 있나요? [순환기] 두근거림/홍통/호흡곤란 [천식] 호흡곤란/쌉쌉거림 [신경계] 경련 [크로친화세포증] 두통/발한 [갑상샘항진증] 더위불내성/체중 감소 [뇌전증] 의식을 잃거나 경련한 적이 있나요? [정신증] 환시/환청 [급성 스트레스장애 및 PTSD] 특정한 사고 후 비슷한 상황, 사고에 대한 생각, 느낌 등을 피하게 되나요?(회피) 특정한 사고 후 예민함/집중장애/수면장애가 생겼나요?(과각성) 특정한 사고 후 반복적이고 집요하게 떠오르는 고통스러운 기억/악몽이 생기지는 않았나요?(재경험)
F	불안감이 더 심해지는 상황이 있나요?/어떨 때 좀 나아지나요?
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?
외	최근에 크게 다치거나 수술 받은 적이 있나요?
과	과거 심장 질환/갑상샘 질환/천식/정신 질환
약	복용하시는 약물이 있나요? (신경안정제, 다이어트약)/하루에 얼마나 드시나요? 실례지만 혹시 대마초나 마약같은 것을 복용하지는 않으시나요? 드시다가 최근에 중단하신 약물은 있나요?

사	음주는 하시나요?/평소 얼마나 드세요?/마지막으로 술 언제 드셨나요? 담배, 커피는 하루에 얼마나 드세요?/직업이 어떻게 되나요? → 스트레스를 많이 받으시나요?
가	가족 중에 비슷한 증상을 호소하시는 분이 계신가요? 가족 중에 정신건강의학과 진료를 받는 분이 계신가요?
여	증상이 생리 주기에 따라 변화가 있나요?/(폐경기 여성의 경우) 폐경기 증상은 어떠세요?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈), 안구 돌출 시진 2. 목★ : 갑상샘 촉진 3. 손★ : 손목 맥박 촉진, 손 뻗게 하여 손떨림 관찰 4. 가슴★ : 심음 청진(최소 5군데)/호흡기계 시진, 촉진, 타진, 청진 5. 피부 : 하지 오목 부종(pitting edema) [누워서] + 크롬친화제포종 의심 시 복부 촉진 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	일상 생활에 지장이 있을 정도로 불안하셔서 많이 힘드셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 갑자기 죽을 것 같은 공포감이 들고, 넓은 장소에 혼자 있을 때 불안감을 느끼는 것으로 보아 김OO님은 현재 공황장애와 광장 공포증이 가장 의심이 됩니다.
감별 진단	하지만 부정맥이 있거나 갑상샘 기능이 과다하거나 배에 종양이 있는 경우에도 비슷한 종류의 불안감을 느낄 수 있습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 심전도검사와 갑상샘기능검사, 소변검사가 필요합니다.
치료	공황장애의 경우 신경안정제와 항우울제로 조절하실 수 있으며, 약물 치료에 더해 인지행동 치료를 지속할 것입니다.
예후	증상이 나타날 때 죽을 것 같은 공포감이 들고 신체에 문제가 있는 것은 아닌가 하는 생각이 드시겠지만 절대 죽는 병이 아니므로 너무 걱정하지 마시고 말씀드린 치료법으로 충분히 증상이 좋아질 수 있으니 안심하셔도 됩니다.

교육	항우울제는 2주 정도 후에야 효과가 나타나기 때문에 꾸준히 약을 복용하시는 것이 중요합니다. 임의로 약을 중단하시면 다시 재발할 가능성이 있으므로 증상이 좋아졌다고 해서 자의로 약을 중단하시면 안 됩니다. 그리고 커피나 녹차 등의 카페인 음료와 술은 증상을 악화시키므로 줄이시는 것이 좋습니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 정신상태검사
- ② Beck 우울척도검사
- ③ 혈액검사 : CBC, TFT, Electrolyte
- ④ 크롬친화세포종 : 소변 metanephrine
- ⑤ 부정맥 : 심전도, 24시간 holter monitoring

❖ 치료 계획

PTSD	증상이 심하면 입원/외상 직후 단기간 위기 개입(충동 극복, 안심, 이완) 약물(SSRI 최소 8주)/인지 행동 치료 Eye movement desensitization and reprocessing(안구 운동 탈민감재처리) : 괴로운 기억을 회상하는 동안 양눈을 좌우로
범불안장애	Buspirone과 BDZ를 함께 쓰다가 2~3주째에 BDZ 줄이기/인지 행동 치료
공황장애 광장공포증	급성 발작 시 BDZ/예기불안에는 BDZ 약물(SSRI, TCA, MAOI, SSRI, BDZ) 인지 행동 치료 : 사소한 신체 변화를 공황장애와 연관시키지 말기, 생명에 위협이 되지 않음을 인식
특정 공포증	인지 행동 치료(체계적 탈감작)/약물(SSRI)
사회불안장애	인지 행동 치료, 집단 치료/약물(SSRI)

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 공감해주기(지금까지 얼마나 힘들었어요?)
- ② 환자 안심시키기, 기질적 원인에 대한 검사도 필요함을 강조
- ③ 약물 치료(이런 불안증의 치료는 효과가 나타나기까지 꾸준히 약을 복용하는 것이 중요/임의 중단 시 재발 가능)가 필요할 수 있고, 약물로 조절 후 점차 감량, 이후 장기적 조절 시 끊을 수 있음을 강조
- ④ 불안장애는 대개 만성화되기 쉽다. 특히 범불안장애는 만성화되기 쉬운 질환이라서 장기간 치료가 필요하다.
- ⑤ 약물 부작용으로 입마름, 변비, 불면, 성기능 장애 → 부작용이 나타나면 병원와서 약물 조절
- ⑥ 술, 담배, 커피를 줄이도록 교육



keyword

불안의 원인 감별하기(정신과적 질환/기질적인 질환(신체 질환, 약물))
불안한 상황에 대해 지지적 상담/안심시키기
약물과 인지 행동 치료로 호전될 수 있음을 교육하기

사실 감정 코멘트



수면장애의 경우 지속 기간 3주를 기간으로 3주 미만이면 일과성, 3주 이상 지속 시 만성으로 분류합니다. 일과성 수면장애의 경우 특히 수면위생의 변화, 스트레스, 약물, 급성 신체 질환 등에 의해 유발될 수 있으므로 관련된 요인을 문진하고, 해당하는 문제들을 먼저 교정하는 시도를 하여야 합니다. 3주 이상 지속되는 만성 수면장애의 경우 우울증과 같은 정신/신경 계통 질환 또는 수면무호흡증, 하지불안증후군과 같은 기질적 문제가 원인이 될 수 있으므로 추가적인 검사를 진행해봐야 합니다. 참고로 수면-각성장애의 경우 **중상이 3개월 이상, 주 3회 이상 지속되는 것이 진단 기준에 포함된 것을 인지하도록 합니다.** 또한 수면의 경우 렘수면과 비렘수면으로 나뉘며, 렘수면에 이상이 있을 시 기면증, 악몽, 렘수면 행동 장애가, 비렘수면에 이상이 있을 시 야경증, 몽유병, 공황발작 등이 발생할 수 있다는 것을 기억하기 바랍니다. **소아의 경우 신경계의 미성숙적 발달로 인해 야경증, 몽유병, 악몽** 등을 나타낼 수 있습니다.

병력 청취 시 **수면장애의 양상, 수면장애의 원인이 되는 정신과적 혹은 신체적 질환의 유무, 수면 위생을 확인**해야 합니다. 수면장애의 양상의 경우 잠들기가 어려운지, 유지가 어려운지, 침대에 얼마나 누워 있으며, 실제 수면 시간은 얼마나 되는지, 수면 주기의 이상이 있는지, 낮에 과도하게 졸린지, 자기는 하나 잔 것 같지 않은지, 코골이가 심한지 등을 확인해야 합니다. 수면위생의 경우 취침 전 저녁에 무엇을 하는지, 잠자리 환경, 잠이 안 오는 경우 대처, 자다 깬 경우 대처 등을 확인해야 합니다.

신체 진찰에서 **내분비 질환 중 갑상샘 질환을 감별하기 위해 목 진찰**을 해야 하며, 심장 질환 및 호흡기 질환 유무를 확인하기 위해 심음 및 호흡기 진찰을 수행해야 합니다. 또한 수면무호흡증의 위험 요소가 있는지 확인하기 위해 **키, 체중, 구강검사를 통해 턱의 폭, 목젖 등을 확인**해야 합니다.

환자 교육 시 **수면위생 개선에 대한 교육**을 하여야 합니다. 저녁에 운동하는 것, 음주 또는 커피 섭취가 많은 것도 수면을 방해하는 요인이므로 이에 대한 조정이 필요하며, 잠이 들지 않을 경우 계속 누워있는 것이 아니라 일어나 명상, 독서 등 몸을 이완시키는 행동을 할 것을 교육해야 합니다. 검사 설명 시 수면다원검사의 경우 검사를 위해 병원에서 하루 자고 가야하며, 일정이 편찮은지 물으면 라보 형성에 도움이 됩니다. 환자가 우울증 등 **정신 질환이 의심되면 심리검사 등의 정신 상태 평가가 필요하다는 것을 잘 설명**해 주어야 합니다. 치료에서 환자가 불면 증상으로 수면제를 요구할 경우 **수면위생 관리 및 행동 치료가 선행돼야 하며, 이후에도 개선이 안 될 시 필요할 때만 수면제를 사용해 부작용을 막는 것이 중요하다고 설명**해줘야 합니다. 소아 환자의 경우 질환의 경과 등을 설명해 부모님을 안심시키는 것도 라보에 도움이 되겠습니다.